

Physioguide — Evidencia — Tests codo, muñeca y mano (expansión)

AlKinora / Physioguide es orientativo: no sustituye criterio clínico ni diagnóstico presencial. Ningún test aislado confirma diagnóstico. No se inventan sensibilidad, especificidad ni likelihood ratios. Si la evidencia es mixta o procede de una sola serie, el texto lo indica.

Capa: Fase 3 evidence DB

Fecha: 31 Aug 2026

Regla: ningún test aislado confirma diagnóstico. No inventar Sn/Sp. Si la evidencia es mixta, decirlo. Preferir cluster + historia + localización. Cribado cervical si hay hormigueo.

Este documento cubre las pruebas que faltaban respecto al claustro de codo, muñeca y mano: Maudsley, Durkan, WHAT, Hook, squeeze de bíceps, moving valgus, milking, Watson, fóvea, press test, piano-key, Froment, Wartenberg, PLRI, LT, CMC lever.

TEST: MAUDSLEY (extensión resistida del 3.er dedo)

Purpose: Cargar el extensor común / ECRB (y, en contexto, el túnel radial) mediante extensión resistida del dedo medio.

Position: Codo extendido o casi extendido. Antebrazo en pronación. Muñeca en neutro. Dedos relajados salvo el 3.º.

Procedure: El examinador resiste la extensión del 3.er dedo (metacarpofalángica), no de toda la muñeca. Registrar si el dolor es familiar y dónde (epicóndilo lateral vs antebrazo proximal dorsal vs cuello).

Positive: Reproduce el dolor habitual en epicóndilo lateral / 1–2 cm distal. Dolor solo en antebrazo proximal dorsal, sin epicóndilo, orienta más a túnel radial / PIN que a LET puro.

Pain location: Epicóndilo lateral !' LET. Antebrazo proximal dorsal (músculo supinador / arcade of Frohse) !' túnel radial. Cuello o irradiación C6–C7 !' no es Maudsley de tendón.

Familiar pain: El de agarrar, verter, ratón, backhand. Si el test crea un dolor nuevo y distinto, pesa poco.

Clinical meaning: Apoya el cluster de LET junto con palpación + Cozen + Mill. No demuestra lesión del nervio radial por sí solo: Maudsley carga ECRB y también puede irritar el túnel radial.

Limitations: Evidencia de precisión aislada limitada (revisiones de exploración de codo, Zwerus et al.). Positivo en LET, túnel radial, radiculopatía C7 (dedo medio), artrosis radio-humeral. No gradúa tendinopatía ni indica infiltración.

Differential: LET, túnel radial / PIN, C6–C7, PLRI (si hay inestabilidad, no solo dolor), cabeza radial.

AI rule: «Duele el hueso de fuera del codo al empujar el dedo del medio hacia atrás !' compatible con codo de tenista en cluster (palpación + Cozen/Mill). Si duele más el antebrazo que el hueso, o hay hormigueo/debilidad de extensión, no cierras LET: piensa túnel radial o cuello. Nunca “Maudsley positivo = nervio radial lesionado”.»

Citation: Maudsley (descripción clásica de carga del 3.er dedo). Coombes BK, Bisset L, Vicenzino B. Management of lateral elbow tendinopathy. *Br J Sports Med* (modelo LET, no impingement). Zwerus EL et al. Physical examination of the elbow: what is the evidence? revisión sistemática — tests individuales de epicondylalgia con utilidad limitada aislados. Literatura de radial tunnel syndrome: solapamiento con LET; Maudsley no discrimina de forma fiable.

TEST: DURKAN / COMPRESIÓN CARPIANA

Purpose: Provocar el nervio mediano comprimiendo el túnel carpiano (mejor complemento de Phalen/Tinel según varias series clínicas).

Position: Antebrazo supinado o neutro. Muñeca en neutro (no hace falta flexión máxima).

Procedure: Ambos pulgares (o un pulgar) del examinador presionan de forma firme y mantenida sobre el túnel carpiano (palma, distal al pliegue palmar, entre palmar mayor y FCR / zona del retináculo). Mantener ~30 s o hasta síntomas. Registrar parestesias familiares en territorio mediano.

Positive: Hormigueo o entumecimiento familiar en pulgar, índice, medio ± mitad radial del anular. Dolor local de muñeca sin parestesias no basta.

Pain location: Dedos medianos. Meñique solo !' cubital, no STC. Irradiación a todo el brazo + cuello !' cribado cervical.

Familiar pain: El hormigueo nocturno / al conducir / al despertar sacudiendo la mano.

Clinical meaning: Apoya el cluster de STC (historia nocturna + territorio mediano + Durkan ± Phalen ± Tinel). La historia (noche, sacudir la mano) pesa tanto o más que cualquier test. Durkan no confirma STC ni sustituye EMG cuando hay duda, déficit motor o cirugía.

Limitations: Series clásicas (Durkan 1991) describieron buen rendimiento; revisiones posteriores (MacDermid, JAMA Rational Clinical Examination) muestran evidencia mixta y heterogeneidad. Falsos positivos en tenosinovitis, muñeca inflamada, mediano proximal. Negativo no descarta STC.

Differential: STC, síndrome del pronador, C6–C7, plexo, tenosinovitis flexora, De Quervain (dolor radial sin hormigueo mediano).

Al rule: «Al apretar el centro de la palma de la muñeca aparece el hormigueo de siempre en pulgar-índice-medio !' compatible con túnel carpiano en cluster. Durkan no confirma STC. Phalen/Tinel negativos no lo descartan. Meñique solo no es STC. Si hay cuello, no te quedes solo en la muñeca.»

Citation: Durkan JA. A new diagnostic test for carpal tunnel syndrome. *J Bone Joint Surg Am.* 1991. D'Arcy CA, McGee S. Does this patient have carpal tunnel syndrome? *JAMA* 2000 (Rational Clinical Examination): historia + cluster > un test; precisión de provocación mixta. MacDermid JC, Wessel J. Clinical diagnosis of carpal tunnel syndrome: a systematic review. JOSPT Carpal Tunnel Syndrome CPG (Erickson et al. 2019). AAOS CTS: no basar el diagnóstico en un único test físico.

TEST: WHAT (Wrist Hyperflexion and Abduction of the Thumb)

Purpose: Provocar el 1.er compartimento dorsal (APL/EPB) de forma más controlada que Eichhoff (pulgar dentro del puño).

Position: Paciente sentado. Examinador sujeta la mano.

Procedure: Muñeca en hiperflexión. El paciente abduce el pulgar activamente contra resistencia del examinador (carga del 1.er compartimento). Palpar el compartimento durante la maniobra. Registrar dolor familiar en estiloides radial.

Positive: Dolor en estiloides radial / 1.er compartimento, el mismo de abrir un bote o usar el pulgar. Tirantez inespecífica del pulgar no basta.

Pain location: Estiloides radial. Base del pulgar (CMC) !' rizartrrosis. Tabaquera profunda post-FOOSH !' escafoides. Palmar + hormigueo 1.º–3.º !' STC.

Familiar pain: Uso del pulgar, pinza, móvil, levantar bebé.

Clinical meaning: Apoya De Quervain en cluster (palpación 1.er compartimento + historia de uso del pulgar ± Finkelstein verdadero). Goubau et al. describieron WHAT como alternativa más específica en comparación con Eichhoff en su serie; no es regla de oro ni confirma tenosinovitis.

Limitations: Un solo estudio de referencia no equivale a cluster validado universal. Positivo en CMC, intersección, escafoides, irritación superficial. Eichhoff (pulgar en el puño + desviación cubital) da más falsos positivos — no usarlo como “el Finkelstein”.

Differential: De Quervain, rizartrrosis CMC, síndrome de intersección, escafoides, STC, fractura estiloides radial.

Al rule: «Duele el canto del pulgar al flexionar la muñeca y abrir el pulgar contra resistencia !' compatible con De Quervain en cluster con palpación. No confirmes por un puño con el pulgar dentro (Eichhoff). Si hubo caída, piensa también en escafoides. Si duele la base del pulgar al pinzar en mayores, piensa CMC.»

Citation: Goubau JF et al. The wrist hyperflexion and abduction of the thumb test: a new provocative test for De Quervain. *J Hand Surg Eur.* 2014. Dawson C, Mudgal CS. Stiff fingers — Finkelstein vs Eichhoff. Literatura De Quervain: cluster clínico (palpación + uso pulgar), no un test aislado.

TEST: HOOK TEST (bíceps distal)

Purpose: Comprobar si el tendón distal del bíceps es enganchable en la fosa antecubital (avulsión completa vs tendón presente).

Position: Codo flexionado ~90°. Antebrazo en supinación máxima. Hombro relajado.

Procedure: Desde el lado lateral de la fosa antecubital, el examinador intenta enganchar el índice bajo el tendón distal del bíceps, tirando hacia delante. Comparar con el lado sano. Registrar si hay cordón tendinoso enganchable.

Positive (para rotura completa): No se puede enganchar un cordón tendinoso (hook negativo / ausente). El lado sano sí se engancha. Complementar: pérdida de contorno, pop al levantar, debilidad de supinación > flexión.

Pain location: Fosa antecubital / antebrazo proximal. El hallazgo clave es ausencia de tendón, no solo dolor.

Familiar pain: El pop y la debilidad al girar un destornillador o levantar un peso, no un dolor de epicóndilo.

Clinical meaning: En la serie original de O'Driscoll et al. (2005) el hook test se describió como muy preciso para avulsiones COMPLETAS. No generalizar a roturas parciales (el tendón puede seguir enganchable). Sospecha alta de rotura completa !' valoración médica urgente (reparación tiempo-dependiente), no “codo de tenista”.

Limitations: Rotura parcial, laceración, hinchazón intensa o paciente que no supina pueden falsear. El lacertus fibrosus intacto puede dar sensación de cordón. No sustituye ecografía/RMN si hay duda.

Differential: Rotura completa vs parcial de bíceps distal, rotura de braquial, luxación/cabeza radial, síndrome del pronador (dolor sin pop ni defecto).

Al rule: «Pop en la parte de delante del codo al levantar + no se nota el tendón al engancharlo + cuesta girar la palma hacia arriba !' sospecha de rotura del bíceps distal. Derivación médica. No lo llames epicondialgia. Hook "enganchable" no descarta rotura parcial.»

Citation: O'Driscoll SW, Goncalves LB, Dietz P. The hook test for distal biceps tendon avulsion. *Am J Sports Med.* 2005. Revisiones de rotura de bíceps distal (JSES / JAAOS): clínica (pop, contorno, supinación débil) + hook; imagen si parcial o dudoso.

TEST: BICEPS SQUEEZE (compresión del bíceps)

Purpose: Complemento del hook: comprimir el vientre del bíceps y observar si se produce supinación pasiva del antebrazo (análogo conceptual al Thompson de Aquiles).

Position: Codo flexionado ~60–80°, antebrazo relajado, semipronado.

Procedure: Comprimir con fuerza el vientre del bíceps. En tendón intacto, el antebrazo tiende a supinar. Ausencia o reducción marcada de supinación vs contralateral !' sospecha de rotura distal.

Positive: Poca o nula supinación al comprimir, con mecanismo de pop/defecto.

Clinical meaning: Apoya rotura distal en cluster con hook, contorno y fuerza de supinación. Menos citado que el hook; no usar aislado.

Limitations: Dolor que inhibe, rotura parcial, técnica variable. Evidencia más limitada que el hook test.

Al rule: Combínalo con hook y el relato del pop. Squeeze solo no confirma ni descarta.

Citation: Ruland RT, Dunbar RP, Bowen JD. The biceps squeeze test for diagnosis of distal biceps tendon ruptures. *Clin Orthop Relat Res.* 2005. Usar como complemento, no como oro.

TEST: MOVING VALGUS STRESS (UCL de codo)

Purpose: Provocar el ligamento colateral cubital (UCL / MCL) del codo en el arco de lanzamiento.

Position: Hombro abducido. Examinador aplica valgo constante mientras mueve el codo.

Procedure: Con valgo mantenido, pasar el codo de flexión hacia extensión (clásicamente el dolor reproductivo se describe en torno a ~70–120° en lanzadores). Comparar con el contralateral. Registrar dolor medial familiar o inestabilidad, no solo tirantez.

Positive: Dolor medial en el trayecto del UCL en el arco de movimiento bajo valgo, el mismo del lanzamiento / aceleración.

Pain location: Epicóndilo medial / UCL. Parestesias 4.º–5.º !' cubital (puede coexistir). Epicóndilo lateral !' no es este test.

Familiar pain: Dolor al lanzar, pérdida de velocidad, sensación de "se abre" por dentro.

Clinical meaning: O'Driscoll et al. (2005) describieron el moving valgus como útil en insuficiencia de UCL en lanzadores. Es cluster clínico (historia de lanzamiento + dolor medial + moving valgus ± milking ± valgo a 30°), no confirmación artroscópica. Evidencia posterior heterogénea; no inventar LR.

Limitations: Dolor por epicondialgia medial o cubital sin inestabilidad. Paciente aprehensivo. No gradúa rotura parcial vs completa.

Differential: UCL, epicondialgia medial, neuropatía cubital, avulsión, osteocondritis (joven lanzador — otro patrón).

Al rule: «Lanzador con dolor por dentro del codo al acelerar + dolor al abrir el codo en valgo mientras se mueve !' compatible con UCL en cluster. No "rotura confirmada". Si hormiguean anular y meñique, criba cubital. No lo trates solo como codo de golfista.»

Citation: O'Driscoll SW, Lawton RL, Smith AM. The "moving valgus stress test" for medial collateral ligament tears of the elbow. *Am J Sports Med.* 2005. Zwerus et al. (evidencia de tests de codo limitada/mixta). Literatura de UCL en overhead athletes (JSES/AJSM): historia de lanzamiento pesa mucho.

TEST: MILKING MANEUVER (UCL de codo)

Purpose: Aplicar valgo al UCL traccionando el pulgar (antebrazo supinado, hombro en RE).

Position: Hombro en rotación externa. Codo flexionado (~70–90°). Antebrazo supinado.

Procedure: El examinador sujeta el pulgar y aplica una fuerza de “ordeño” que genera valgo en el codo. Variante: milking en 70°. Registrar dolor medial familiar o sensación de apertura.

Positive: Dolor/inestabilidad medial familiar, comparable al moving valgus.

Clinical meaning: Complemento del moving valgus y del valgo a 0°/30°. Útil cuando el moving valgus es difícil. No confirma grado.

Limitations: Molesto. Positivo en tendinopatía medial. Comparar siempre contralateral.

AI rule: Úsalo en el cluster de UCL con moving valgus e historia de lanzamiento. Aislado no diagnóstica.

Citation: Literatura de exploración de UCL (milking / modified milking). O'Driscoll moving valgus como pieza central del cluster; milking como complemento clínico.

TEST: VALGO / VARO DE CODO (0° y ~30°)

Purpose: Cribar laxitud del UCL (valgo) o del LCL (varo) en extensión y en ligera flexión (desbloquea olécranon).

Procedure: Estabilizar húmero. Aplicar valgo o varo. Comparar apertura y calidad de tope vs contralateral. Dolor vs inestabilidad verdadera.

Positive: Apertura aumentada + tope blando + síntomas familiares. Dolor sin laxitud = inespecífico (tendón o cubital).

AI rule: Dolor medial al valgo ~ rotura de UCL. Laxitud clara + historia de inestabilidad sí sube sospecha. Varo + sensación de que el codo se va hacia atrás al empujarse !' pensar PLRI, no solo “esguince”.

Citation: Exploración estándar de codo (Morrey/O'Driscoll). Zwerus: evidencia cuantitativa limitada.

TEST: WATSON / SCAPHOID SHIFT (inestabilidad escafolunar)

Purpose: Detectar inestabilidad del intervalo escafolunar (ligamento SL) desplazando el escafoides mientras se mueve la muñeca.

Position: Codo apoyado. Examinador pulgar sobre el tubérculo del escafoides (palmar, distal al radio).

Procedure: Partir de desviación cubital (escafoides extendido). Presionar el tubérculo y llevar la muñeca a desviación radial (el escafoides debería flexionar; si el SL está incompetente puede subluxar y “resaltar” al soltar). Registrar dolor dorsal en intervalo SL, resalte o aprensión.

Positive: Dolor dorsal central/SL familiar ± clunk/resalte ± sensación de inestabilidad. Dolor radial puro de De Quervain no es un Watson positivo.

Pain location: Dorso de muñeca, proximal a la base del 3.er metacarpiano (intervalo SL). Tabaquera post-trauma !' escafoides óseo primero.

Familiar pain: Dolor al cargar la muñeca, flexión dorsal, “cedió” tras caída.

Clinical meaning: Compatible con inestabilidad SL en cluster (dolor SL + Watson + ballotement ± historia de FOOSH). Watson es operador-dependiente y puede ser positivo en muñecas laxas asintomáticas. No confirma disociación SL ni sustituye RX (brecha de Terry-Thomas) / RMN.

Limitations: Falsos positivos en hiperlaxitud. Doloroso. Contraindicado si fractura de escafoides no excluida (FOOSH + tabaquera !' imagen primero).

Differential: Inestabilidad SL, fractura escafoides, ganglión dorsal, tendinopatía, TFCC (dolor cubital, no SL).

AI rule: «Tras una caída, duele el dorso del centro de la muñeca y “salta” al moverla con presión en el escafoides !' compatible con inestabilidad escafolunar en cluster. Si la tabaquera duele, primero RX de escafoides. Watson no confirma rotura del ligamento.»

Citation: Watson HK, Ashmead D 4th, Makhlof MV. Examination of the scaphoid. *J Hand Surg Am.* 1988. Revisiones de SLAC / disociación SL (JHS): clínica + imagen; tests físicos con precisión variable.

TEST: SIGNO DE LA FÓVEA CUBITAL (ulnar fovea sign)

Purpose: Palpar la fóvea cubital (punto blando entre estiloides cubital y FCU/ECU) como cribado de dolor TFCC / inserción foveal.

Position: Muñeca neutra. Examinador índice en la fóvea cubital (palmar-cubital, distal al cúbito).

Procedure: Presión firme en la fóvea. Comparar contralateral. Positivo si reproduce el dolor cubital familiar.

Positive: Dolor exquisito en fóvea, el de girar un destornillador o apoyarse sobre la mano.

Pain location: Lado cubital de la muñeca (meñique). Estiloides radial !' no TFCC. Pisiforme/Guyon !' cubital distal.

Clinical meaning: Tay et al. (2007) describieron el fovea sign como útil para patología foveal/TFCC en su serie. Es cribado de localización, no artroscopia. Combinar con press test, carga cubital y piano-key.

Limitations: Palpación dolorosa en muchas muñecas cubitales (ECU, LT, pisotriquetral, fractura estiloides cubital). Evidencia posterior no convierte el signo en diagnóstico único.

AI rule: «Duele el huequito del lado del meñique al apretarlo !' compatible con TFCC en cluster (giro, apoyo, carga cubital). No "TFCC confirmado". Si la muñeca se hunde como tecla de piano, piensa también DRUJ.»

Citation: Tay SC, Tomita K, Berger RA. The "ulnar fovea sign" for defining ulnar wrist pain: an evaluation of sensitivity and specificity. *J Hand Surg Am.* 2007 — citar como serie; no extrapolar cifras a toda consulta. Literatura TFCC (Palmer/classificación): clínica + imagen/artroscopia.

TEST: PRESS TEST (TFCC)

Purpose: Cargar la muñeca cubital al levantarse de una silla con las manos (compresión + rotación).

Procedure: Paciente intenta levantarse empujando el asiento con la palma (o ambas). Dolor cubital familiar = positivo.

Clinical meaning: Lester et al. describieron el press test en dolor cubital / TFCC. Complemento de fóvea y grind. No específico (ECU, DRUJ, artrosis cubitocarpiana).

AI rule: Dolor al apoyarse para levantarse en el lado del meñique apoya TFCC en cluster, no confirma.

Citation: Lester B, Halbrecht J, Levy IM, Gaudinez R. "Press test" for ulnar-sided wrist pain. *J Hand Surg Am* / literatura TFCC clínica.

TEST: CARGA CUBITAL / ULNAR GRIND (ya en catálogo como tfcc-ulnar-load)

Purpose: Desviación cubital + carga axial ± pronosupinación para provocar TFCC / ulnocarpiano.

Positive: Dolor cubital familiar, no crepitación inespecífica.

AI rule: Ya usado en el catálogo ilustrado. Combinar con fóvea y piano-key. Trauma + dolor cubital persistente !' no "esguince" eterno sin imagen.

Citation: Exploración ulnocarpiana estándar; evidencia de tests aislados mixta.

TEST: PIANO-KEY / BALLOTEMENT DRUJ

Purpose: Valorar estabilidad de la articulación radiocubital distal (DRUJ): el cúbito distal se deprime como tecla de piano respecto al radio.

Position: Antebrazo en pronación (variante en neutro/supinación). Examinador estabiliza el radio y presiona el cabeza cubital dorsal.

Procedure: Empujar la cabeza cubital palmarmente y soltar. Comparar traslación y tope con el lado sano. Registrar dolor, clunk, sensación de inestabilidad, no solo "se mueve" (muchas DRUJ son fisiológicamente móviles).

Positive: Traslación aumentada asimétrica + dolor familiar ± clunk al girar. Laxitud indolora bilateral en hiperlaxos "" DRUJ patológica.

Pain location: Dorso cubital distal, estiloides cubital. Fóvea palmar !' TFCC. ECU dorsal !' tendón.

Clinical meaning: Compatible con inestabilidad DRUJ en cluster (trauma de pronosupinación, dolor al girar, piano-key asimétrico, press test). TFCC y DRUJ se solapan: el TFCC es estabilizador clave de la DRUJ. No confirmar grado sin imagen/especialista.

Limitations: Alta variabilidad. Hiperlaxitud. Fractura de radio distal mal consolidada. No forzar si fractura aguda.

AI rule: «La muñeca del lado del meñique se hunde como una tecla y duele al girar la palma !' compatible con inestabilidad radiocubital distal en cluster. Compárala con la otra. Laxitud sin dolor no basta. Puede ir con TFCC.»

Citation: Adams BD. Distal radioulnar joint instability. literatura JHS/JAAOS. Ballottement / piano-key como exploración estándar; precisión cuantitativa limitada.

TEST: FROMENT (signo de Froment)

Purpose: Cribar debilidad del aductor del pulgar (cubital): al pinzar un papel, el pulgar flexiona la IF (compensa con FPL, mediano).

Position: Papel entre pulgar e índice (pinza lateral).

Procedure: El paciente sujeta el papel; el examinador tira suavemente. Observar si la IF del pulgar se flexiona (Froment positivo) vs pinza con IF extendida (normal).

Positive: Flexión IF del pulgar al pinzar, o imposibilidad de retener el papel, en contexto de síntomas cubitales.

Clinical meaning: Apoya déficit motor cubital (túnel cubital o Guyon). No localiza codo vs muñeca por sí solo.

Historia (flexión de codo vs cicatriz de Guyon / manillar) + Tinel + territorio 4.^o–5.^o.

Limitations: Dolor de pulgar (UCL, CMC) puede imitar pinza rara. No es test de STC.

Al rule: «Al sujetar un papel con el pulgar se le dobla la yema y se le escapa, con hormigueo de anular y meñique !' compatible con cubital con déficit motor. No es túnel carpiano. Valoración; no solo “codo de golfista”.»

Citation: Signo clásico de Froment. Novak/Mackinnon ulnar neuropathy. Elbow flexion test (Buehler) para provocación en codo; Froment para motor.

TEST: WARTENBERG (signo digital cubital)

Purpose: Cribar debilidad de los interóseos palmares / aducción del 5.^o dedo: el meñique queda abducido (“se queda fuera”).

Procedure: Paciente intenta juntar los dedos. El 5.^o permanece en abducción. Comparar.

Positive: Abducción persistente del meñique en contexto cubital.

Clinical meaning: Complemento de Froment. Más de déficit establecido que de cribado precoz.

Al rule: Meñique que no se junta + hormigueo 4.^o–5.^o !' cubital motor. No STC.

Citation: Signo de Wartenberg (ulnar). Práctica clínica de neuropatía cubital.

TEST: LATERAL PIVOT-SHIFT / CHAIR PUSH-UP / TABLETOP (PLRI)

Purpose: Cribar inestabilidad posterolateral rotatoria (PLRI) por insuficiencia del complejo LCL / LUCL.

Lateral pivot-shift (O'Driscoll): Paciente en supino. Supinación + valgo + carga axial mientras se flexiona el codo. Busca aprensión o subluxación posterolateral de la cabeza radial (a menudo el paciente no deja completar el test).

Chair push-up: Paciente se levanta de la silla con brazos, palmas al asiento (antebrazo supinado). Sensación de que el codo se va / dolor posterolateral.

Tabletop relocation: Apoyo sobre mesa con palma; el examinador puede relocalizar la cabeza radial y aliviar la aprensión.

Positive: Aprensión o clunk de inestabilidad posterolateral, no solo dolor de epicóndilo.

Clinical meaning: Cluster de PLRI (antecedente de luxación o caída + aprensión al empujarse con palma arriba + pivot-shift/chair). Tests de provocación especializados y molestos. No usar como banco de preguntas SÍ/NO al paciente. No confirman sin clínica experta/imagen.

Limitations: Baja tolerancia. Falsos por dolor LET. Evidencia cuantitativa limitada.

Al rule: «Tras una luxación o un apoyo fuerte, el codo “se va” al empujarse con la palma hacia arriba !' compatible con inestabilidad posterolateral. No es codo de tenista. No pidas que se haga un pivot-shift en casa. Derivación.»

Citation: O'Driscoll SW. Posterolateral rotatory instability of the elbow. *J Bone Joint Surg Am* / Instructional Course. Chair sign / tabletop relocation en literatura de PLRI. Zwerus: evidencia de tests limitada.

TEST: BALLOTEMENT LUNOPIRAMIDAL / REAGAN / KLEINMAN SHEAR (LT)

Purpose: Cribar inestabilidad del intervalo lunopiramidal (ligamento LT), diferencial cubital dorsal vs TFCC.

Ballotement / Reagan: Fijar semilunar y desplazar piramidal palmar-dorsal (o viceversa). Dolor + holgura vs contralateral.

Kleinman shear: Cizalla del intervalo LT.

Positive: Dolor en intervalo LT (dorso cubital, más radial que la fovea pura) + holgura.

Clinical meaning: Cluster de LT (dolor cubital dorsal + shear/ballotement + menos fovea/press que el TFCC típico). Precisión limitada. Imagen/especialista si persiste.

Al rule: Dolor cubital no es siempre TFCC. Si duele más el dorso entre huesos al “mover una fila contra la otra”, piensa LT. No confirmes con un solo shear.

Citation: Reagan DS, Linscheid RL, Dobyns JH. Lunotriquetral sprains. *J Hand Surg Am.* Kleinman shear. Revisiones de inestabilidad carpiana cubital (JHS): clínica difícil; imagen.

TEST: CMC LEVER (rizartrosis)

Purpose: Complemento del grind: palanca de la base del 1.er metacarpiano sobre el trapecio.

Procedure: Estabilizar trapecio. Palanca dorsal/radial del metacarpiano. Dolor CMC familiar ± crepitación.

Positive: Dolor en la base del pulgar (CMC), no en estiloides (De Quervain) ni tabaquera (escafoides).

Clinical meaning: Cluster de OA CMC (edad, pinza dolorosa, grind + lever + palpación CMC). Grind ya está en catálogo. Lever es complemento clínico; no métricas robustas aisladas.

AI rule: Duele la base del pulgar al palancar/moler + pinza débil en adulto !' compatible con artrosis CMC. No lo llames De Quervain si el 1.er compartimento está silente.

Citation: Literatura de trapeciometacarpiana OA (grind test clásico). Lever como variante clínica; no inventar Sn/Sp.

REGLAS TRANSVERSALES PARA LA IA

1. Nunca: un test positivo = diagnóstico confirmado.
2. Nunca inventar sensibilidad, especificidad ni likelihood ratios.
3. Historia + localización + dolor familiar "e test especial.
4. Hormigueo !' territorio (mediano / cubital / radial / cervical) antes de tendón.
5. FOOSH + tabaquera !' escafoides / imagen antes de Watson agresivo.
6. Pop antecubital + hook ausente !' bíceps distal, no LET.
7. Lanzador + dolor medial al valgo dinámico !' UCL en cluster, no solo golfista.
8. Dolor cubital de muñeca !' TFCC y DRUJ y LT y ECU; no un solo saco.
9. Citar; si la evidencia es una serie única, decirlo.

